

Live

Справочник
Заболевания

Угри (акне)



Маргарита Жизневская

4.2

Акне — распространённое заболевание, которое проявляется комедонами, папулами, пустулами и кистами на коже. Болезнь часто встречается у подростков в период полового созревания, но может развиваться и во взрослом возрасте. Разбираемся, из-за чего возникает угревая сыпь и как с ней правильно бороться.

виды акне

Признаки и симптомы акне

Осложнения акне

Диагностика акне

Лечение акне

Прогноз акне

Кто вас переваривает?

Скидка до 18% на диагностику хеликобактер пилори →

Каждый месяц дарим подарки и делаем скидки до 30% 🎁
Начните экономить прямо сейчас!

Фамилия

Имя

Дата рождения

День

Месяц

Год

Пол

☐

Женский

☐

Мужской

Код

+7

Номер телефона

Даю согласие

☐ На обработку ПДн☐ На получение писем

Подписаться

Что такое акне

Акне, или угревая сыпь, — одно из самых распространённых хронических неинфекционных кожных заболеваний. При акне на поверхности кожи появляются высыпания: открытые или закрытые комедоны, папулы, пустулы и кисты — иными словами, прыщи. Воспалительные элементы при акне чаще всего появляются на коже лица, верхней части спины и груди, так как в этих местах больше всего сальных желёз.

Акне встречается у 85% людей от 12 до 25 лет, а у 8% сохраняется до 34 лет.

Обычно акне не вредит здоровью и общему самочувствию, но вызывает психологический дискомфорт. Особенно сильно появление прыщей влияет на подростков в период полового созревания. Количество высыпаний определяет их самооценку и поведение в обществе, а в тяжёлых случаях может привести к депрессии и суицидальным мыслям.

Почему появляется угревая сыпь

Чтобы понять, почему появляются прыщи, нужно разобраться, как устроена кожа и какие процессы в норме в ней происходят.

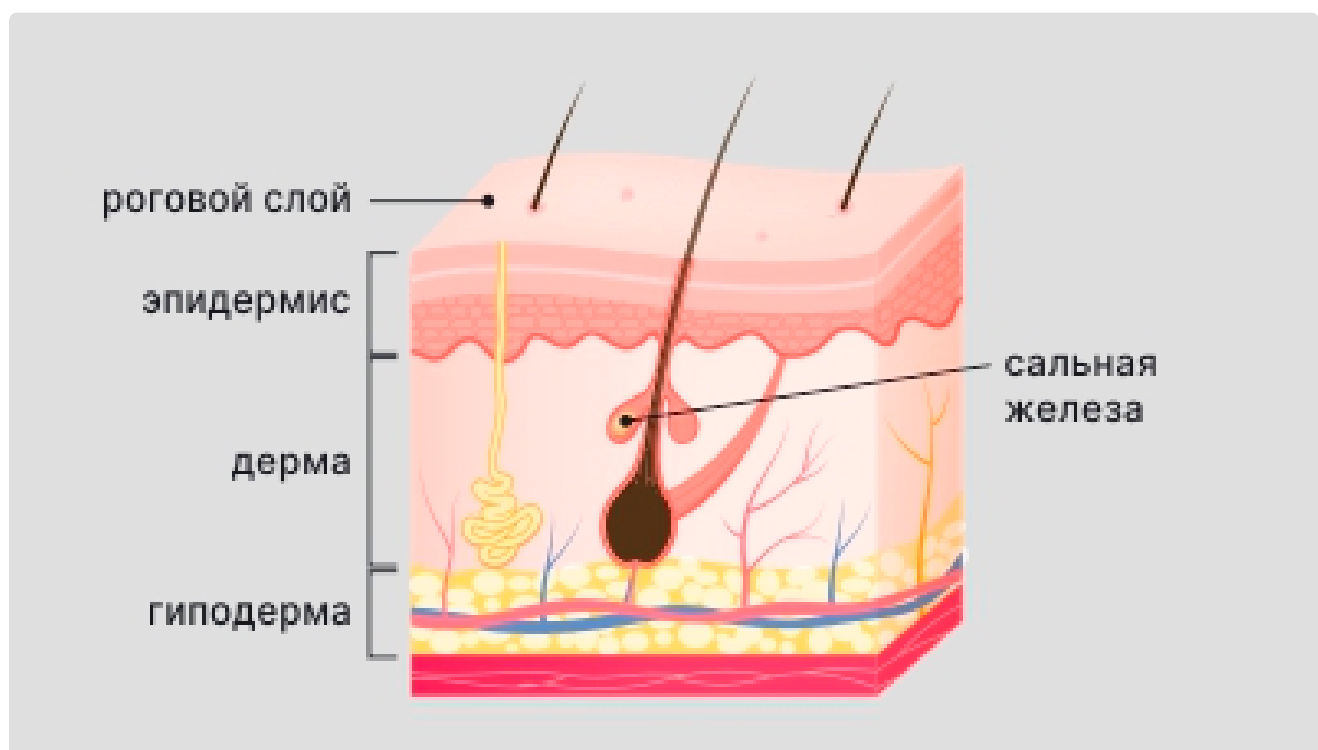
Как устроена кожа

Кожа — самый большой орган в теле человека. Она участвует в обмене кислорода и углекислого газа, передаёт тактильные ощущения, регулирует температуру тела, синтезирует витамин D, который нужен для усвоения кальция. Одним словом, она выполняет много функций, но главное — служит герметичным барьером между внутренними системами

Дерма — второй слой кожи, который отвечает за её эластичность и упругость. Именно в дерме происходят основные обменные процессы.

Самый верхний, роговой, слой кожи — эпидермис. Он состоит из особых клеток — кератиноцитов, которые выполняют роль щита: предохраняют дерму от повреждений, а также удерживают в ней влагу.

Эпидермис непрерывно обновляется: старые кератиноциты отшелушиваются и замещаются новыми. Этот процесс необходим для поддержания защитных функций кожи. Случивание эпидермиса на всём теле занимает около месяца и происходит в среднем 12–14 раз в год.



Строение кожи

Однако эпидермису тоже нужна защита, иначе он будет слишком быстро «изнашиваться». Для этого в коже есть сальные железы, вырабатывающие кожное сало — себум. Это вещество дополнительно увлажняет кожу, поддерживает баланс полезных бактерий на её поверхности, а также защищает от внешних факторов — инфекций, пыли и ультрафиолета.

Механизм развития акне

В норме себум — это жир, по консистенции напоминающий растительное масло.

желёз. Смесь кожного сала и слущивающихся кератиноцитов (клеток кожи) забивает поры, как пробка, и на коже образуются угри.

Избыток себума может быть связан с дисбалансом гормонов, эндокринными заболеваниями, неправильным уходом, а также с приёмом некоторых препаратов.

Кроме того, чрезмерно жирная кожа — отличная среда для размножения патогенных микроорганизмов, которые провоцируют сильное воспаление в закупоренных сальных протоках.

Таким образом, в основе акне лежат три основных фактора:

- избыток секрета сальных желёз,
- ускоренное отшелушивание кератиноцитов.
- в некоторых случаях — присоединение бактериальной инфекции.

Причины акне

Более чем в 80% случаев причина акне — генетическая предрасположенность. Заболевание часто наследуется от родителей, у которых акне проявлялось в подростковый период или сохраняется и во взрослом возрасте.

Угревая сыпь может появиться при изменениях в генах, которые кодируют особенности работы сальных желёз, скорость обновления эпидермиса и восприимчивость кожи к андрогенам (мужским половым гормонам, которые вырабатываются и в организме женщин, но в меньшем количестве, чем у мужчин).

При повышенной чувствительности к мужским половым гормонам вырабатывается больше себума, а клетки кожи быстрее отшелушиваются. Смесь вязкого кожного сала и кератиноцитов забивает поры, и в них появляются угри — белые или чёрные точки.

Другой причиной акне, особенно частой у подростков, может быть высокий уровень мужских половых гормонов. В период полового созревания гормональный фон активно меняется и в кровь выбрасывается большое количество андрогенов.

У мальчиков эти гормоны выполняют прямую функцию: участвуют в развитии репродуктивной системы, формировании скелета, мускулатуры и всех тех признаков,

В результате их быстро поглощает кожа. Дальше всё происходит по уже описанной схеме: вырабатывается много кожного сала, активно слущиваются кератиноциты, забиваются поры и появляются прыщи.

Акне у взрослых

В зрелом возрасте большого количества прыщей на коже в норме быть не должно. Акне у взрослых может говорить об избытке андрогенов — **гиперандрогении**. Она встречается при некоторых эндокринных патологиях, например при нарушении функций коры надпочечников, которая активно вырабатывает мужские половые гормоны.

У взрослых женщин перед менструацией тоже часто появляются прыщи. Это связано с естественным повышением уровня андрогенов в конце цикла.

Кроме того, у женщин причиной гиперандрогении могут быть заболевания репродуктивной системы — довольно часто уровень мужских половых гормонов повышается из-за **поликистоза яичников**.

Некоторые **кожные инфекции** тоже вызывают угревую сыпь. Чаще всего в роли возбудителя выступают бактерии *Propionibacterium acnes* (пропионибактерия акне) и *Propionibacterium granulosum* (пропионибактерия гранулосум), а также стафилококки и кожные клещи (например, *Demodex*). В норме эти микроорганизмы — условные патогены. То есть они не вызывают заболевание, если нет определённых условий. В данном случае микроорганизмы активизируются и начинают вредить при избыточной выработке кожного сала.

Частое умывание — довольно распространённая причина прыщей у людей с жирной кожей. Её обладатели постоянно стремятся убрать лишний себум водой, мылом, спиртовыми лосьонами или влажными салфетками. Однако избыточное очищение кожи — чаще чем два раза в день — провоцирует гиперсекрецию кожного сала, что, в свою очередь, создаёт высокий риск возникновения новых воспалительных элементов и не помогает в борьбе с уже имеющимися высыпаниями.

Использование комедогенной косметики — возможная причина акне. Она забивает поры и препятствует оттоку себума из сальных желёз.

Распространённая комедогенная декоративная косметика — силиконовые базы под макияж и тональные средства, которые улучшают внешний вид кожи за счёт сглаживания неровностей. Из косметики для ухода повышенной комедогенностью обладают средства,

Но если умываться слишком агрессивными средствами или часто использовать скрабы, пилинги и другие отшелушивающие косметические продукты, барьерная функция эпидермиса нарушится. Пытаясь защититься от грубого внешнего воздействия, кожа будет вырабатывать больше себума, который закупорит поры и создаст благоприятные условия для болезнетворных микроорганизмов.

Механические травмы, в том числе выдавливание угрей и гнойничков, — не первопричина появления прыщей, но фактор, который может привести к увеличению количества высыпаний и развитию акне. Во-первых, при травмировании инфекция проникает глубже в кожу — в таком случае из небольшого прыщика может получиться большая киста. Во-вторых, патоген разносится с руками на здоровые участки кожи и может осесть там. Это спровоцирует появление ещё нескольких прыщей, и так по цепочке.

Акне у детей

У новорождённых акне появляется в 20% случаев в первый месяц жизни. Это может быть связано как с изменением гормонального фона ребёнка после рождения, так и с приёмом матерью гормональных препаратов в последний триместр беременности. Обычно высыпания сами исчезают в течение 2 недель и не оставляют следов.

Однако у некоторых детей, чаще у мальчиков, прыщики могут сохраняться и дольше — до года. В таком случае говорят об инфантильном акне, которое может быть связано с наследственным увеличением сальных желёз, повышенной чувствительностью кожи к андрогенам или избытком этих гормонов. Если в младенчестве у ребёнка долго не проходят угри, это может говорить о риске тяжёлого течения акне в подростковом возрасте.

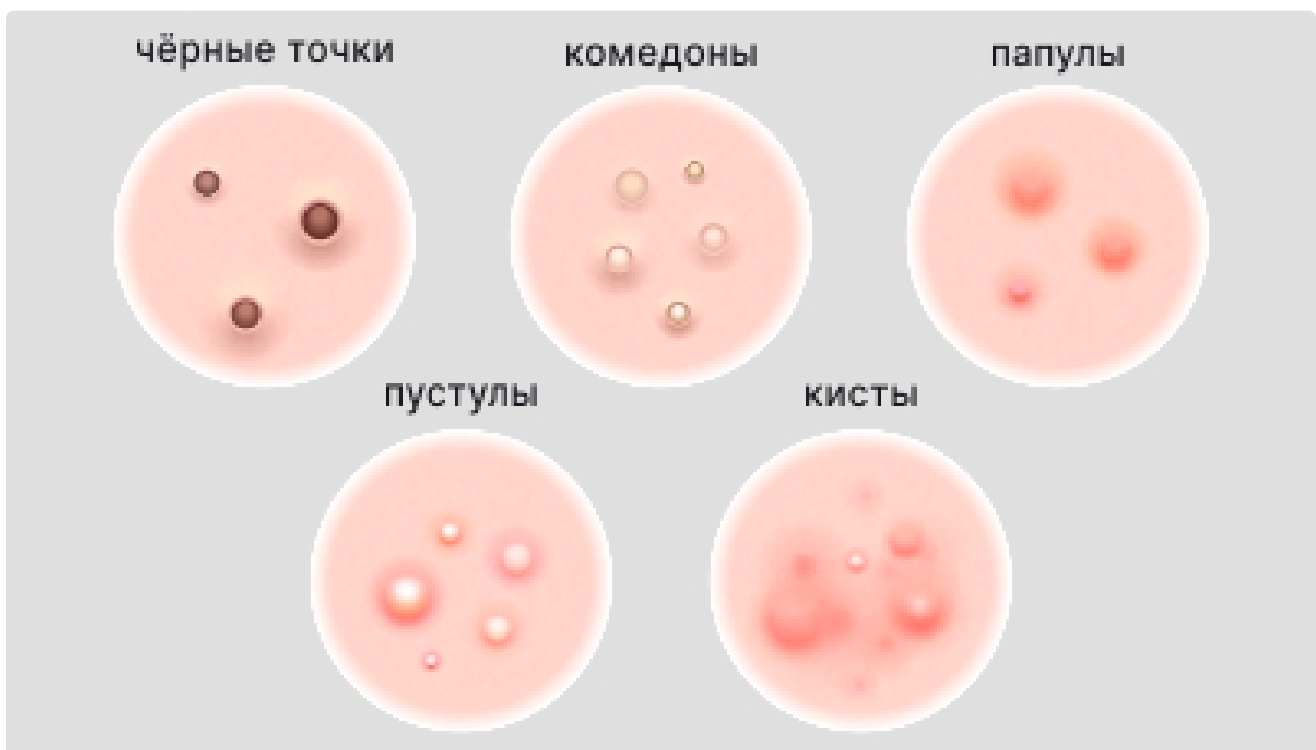
У детей до 7 лет акне развивается редко. Чаще всего появление угрей связано с избытком андрогенов (например, при раннем половом созревании) или другими эндокринными нарушениями.

Ближе к подростковому возрасту акне может возникнуть из-за изменения гормонального фона при половом созревании. Незначительные высыпания, как правило, проходят вместе со стабилизацией уровня гормонов. Однако тяжёлые формы акне требуют обследования и лечения.

Виды акне

невоспалённые точки, приподнятые над поверхностью кожи;

- папулы — поверхностные воспалительные узелки (прыщи) красного цвета, не имеющие белой головки. Как правило, болезненны и могут оставлять поствоспалительную пигментацию (застойные пятна);
- пустулы — похожи на папулы, но у них есть гнойная головка. Иногда пустулы самостоятельно разрываются и из них вытекает гнойное содержимое. Могут оставлять рубцы при выдавливании;
- узлы, или кисты — объединение нескольких папул в одно большое воспалённое уплотнение, содержащее гной. Обычно киста образуется в местах скопления воспалений. После кист всегда остаются рубцы.



Типы высыпаний при акне

После выдавливания или самостоятельного прорыва гноя из папул, пустул и кист на их месте остаются расширенные поры. Они делают рельеф кожи неровным и служат дополнительным источником новых комедонов, так как в образовавшиеся полости легко забивается грязь.

Форму акне определяет степень поражения кожи. Чем больше папул и пустул, тем тяжелее болезнь.

Формы акне:

пигментные («застойные») пятна, но кист и рубцов нет;

- тяжёлая папуло-пустулёзная или узловатая умеренной степени тяжести — много комедонов (от 26 до 50), папул и пустул (от 21 до 30), узлы и кисты в небольшом количестве (менее 5). Присутствует сильное воспаление, пигментные пятна. На местах высыпаний часто образуются рубцы, иногда келоиды — кожные наросты;
- узловатая тяжёлой степени, конглобатная — много комедонов (более 50), много папул и пустул (более 30), количество узлов и кист — более 5 штук. Наблюдается сильное воспаление и выраженные пигментные изменения кожи, на местах высыпаний образуются глубокие рубцы или келоиды.



Папуло-пустулёзная форма акне

Признаки и симптомы акне

Основной признак акне — появление множественных высыпаний. Чаще всего прыщи при акне появляются на лице. Это связано с обилием сальных желёз в этой области, а также с тем, что лицо постоянно открыто — значит, болезнетворные микроорганизмы и пыль с лёгкостью попадают на поверхность кожи.

Ещё акне может распространиться на спину и грудь, если сальные железы в этой области

Комедоны, как правило, не доставляют физического дискомфорта, но могут вызвать умеренный зуд. При формировании папул, пустул и кист кожа в поражённых местах краснеет, становится горячей. Появляется боль, которая усиливается при касании или надавливании на прыщ.

Если папул или кист много, может ухудшиться общее состояние пациента: поднимается температура до 38 °С, появляется слабость. После механического удаления гнойных воспалений или при их самостоятельном разрыве на коже образуются ранки. Иногда на месте прыщей остаются тёмные застойные пятна, похожие на синяки. Они долго рассасываются и портят внешний вид.



Застойные пятна при акне

Кроме того, большинство пациентов с акне отмечают, что их кожа слишком жирная. После умывания она довольно быстро покрывается масляным слоем себума. Особый дискомфорт это доставляет женщинам, использующим декоративную косметику: она начинает скатываться, забиваться в морщинки и поры.

Осложнения акне

- расширенные поры — появляются из-за того, что угри растягивают кожу;
- рубцы — образуются на местах, где были пустулы или кисты. Как правило, они развиваются из-за повреждения среднего слоя кожи — дермы;
- застойные пятна — синевато-красные точки, напоминающие маленькие синяки. Возникают на месте гнойных воспалений и кист из-за травматизации дермы. Могут сохраняться месяцами;
- пигментные пятна — локальный загар, появляется при воздействии ультрафиолета на травмированную кожу.



Рубцы и расширенные поры при постакне

Ещё одно распространённое осложнение акне — **атерома**, или киста сальной железы. От обычной кисты отличается размерами, а также строением. В отличие от кисты, в атероме накопившееся кожное сало обрастает плотной оболочкой из соединительной ткани и образует твёрдую капсулу.

Иногда атеромы нагнаиваются, самостоятельно разрываются и из них выходит содержимое. Однако если не удалить из-под кожи оболочку, атерома появится снова.

Также при неудачном выдавливании прыща может развиваться **сепсис** (заражение крови) и инфекция распространится по всему организму. Чаще всего такое происходит, когда содержимое пустулы или кисты выдавливается не наружу, а внутрь — в глубокие слои

на самооценку и могут служить причиной насмешек. На фоне переживаний из-за внешнего вида кожи может развиваться апатия и депрессия. У некоторых пациентов отмечаются суицидальные мысли.

Как правило, риск психологических проблем зависит от тяжести болезни и ряда других факторов: возможности замаскировать угри, отношения к внешнему виду кожи с акне семьи, друзей и близкого окружения.

Диагностика акне

Прежде всего врач спросит о жалобах, времени появления симптомов, хронических заболеваниях у пациента и в семье, а также о приёме лекарственных препаратов на постоянной основе.

Затем специалист осмотрит кожу и оценит степень её поражения. Поинтересуется, как именно пациент ухаживает за ней: как часто умывается или моется, какие средства использует для очищения и увлажнения.

Для оценки общего состояния здоровья и силы воспаления врач порекомендует сдать клинический анализ крови, а также соскоб с кожи — он позволит выявить патогенные микроорганизмы.

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь)

89 бонусов

890 ₽



В корзину

 1 день

Вен. кровь

330 ₽

Анализ микробиоты по Осипову: кожа

531 бонус

Кожа 0 ₹

Анализ на демодекс (ресницы, кожа)

58 бонусов

580 ₹



В корзину

? 1 день

Ресницы, кожа 0 ₹

Врач может также направить пациента на исследование уровня гормонов в крови. Это связано с тем, что акне часто возникает из-за гормональных нарушений.

Свободный тестостерон

158 бонусов

1 580 ₹



В корзину

? 2 дня

Вен. кровь 330 ₹

ДГА-S

75 бонусов

750 ₹



В корзину

? 1 день

Вен. кровь 330 ₹

780 ₽



В корзину

1 день

Вен. кровь

330 ₽

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

78 бонусов

780 ₽



В корзину

1 день

Вен. кровь

330 ₽

Андростендион (слюна, ВЭЖХ)

174 бонуса

1 740 ₽



В корзину

6 дней

Слюна

0 ₽

К какому врачу обращаться с акне

Диагностикой и лечением акне занимается дерматолог. При необходимости он направит пациента к эндокринологу, гинекологу или другим специалистам.

Лечение акне

Акне в лёгкой форме, как правило, лечится препаратами для наружного применения,

средства для домашнего использования и расскажет об этапах правильного ухода за кожей.

При средней степени акне и более тяжёлых формах наружная терапия сочетается с приёмом препаратов внутрь (системная терапия). В первом случае применяются топические ретиноиды, бензоилпероксид, антибактериальные средства, во втором — антибактериальные препараты или изотретиноин.

При выявленных гормональных нарушениях назначают гормональные препараты, в том числе пероральные контрацептивы.

После улучшения состояния пациенту всегда назначается поддерживающая терапия.

В тяжёлых случаях применяется только системная терапия. Пациенту назначают препараты с изотретиноином. Они облегчают отшелушивание клеток кожи, снижают активность сальных желёз и минимизируют риск их закупорки и воспаления. Препараты с изотретиноином безопасны, но обладают рядом побочных эффектов. Лечение такими средствами проводится только по назначению врача и под строгим медицинским контролем дерматолога. Женщинам детородного возраста при такой терапии назначаются надёжные средства контрацепции.

Если у пациента на фоне переживаний из-за акне появились психологические нарушения — неуверенность в себе, апатия, депрессия, проблемы с общением в коллективе, — может потребоваться консультация психолога или психотерапевта.

Как ухаживать за кожей с акне

Оптимальную схему ухода может составить врач-дерматолог или косметолог. Средства и последовательность их применения зависят от длительности заболевания, причин его возникновения и степени поражения кожи. Любой уход включает в себя минимум два этапа: очищение и увлажнение.

На первом этапе ухода важно не нарушить естественную микрофлору и не пересушить кожу, но при этом эффективно удалить загрязнения и кожное сало.

На втором этапе следует использовать некомедогенные увлажняющие средства. Они не забивают поры, помогают сохранить кожу упругой, избежать шелушений. В зависимости от ингредиентов в составе, средства также могут убрать покраснения, снять воспаление и зуд, подсушить пустулы и улучшить цвет лица.

Диета при акне

маслам и полиненасыщенным жирным кислотам (рыбий жир, омега-3).

Прогноз акне

В некоторых случаях, например при генетической предрасположенности, полностью вылечить акне нельзя. При любых неблагоприятных обстоятельствах (неправильный уход, гормональные сбои) болезнь будет рецидивировать.

Однако добиться длительной ремиссии и улучшения внешнего вида кожи можно на любой стадии. Для этого необходима комплексная диагностика, строгое выполнение назначений врача, регулярные косметологические процедуры и подбор правильных средств для домашнего ухода за кожей.

При своевременном обращении за медицинской помощью прогноз благоприятный.

Частые вопросы

Что такое угри?

Какой врач лечит акне?

Как избавиться от акне?

Какие анализы сдавать при акне?

Нужно ли лечить акне?

Как долго лечится акне?

Можно ли загорать при акне?

Справочник

Заболевания

Информацию проверил
врач-эксперт



Александра Филёва
Врач-дерматовенеролог

Написано 19.01.2023 в 06:40.
Редактировалось 26.02.2024 в 18:45.
Проверено экспертом 26.02.2024 в 18:45.

Оцените статью:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полезная статья? Поделитесь в социальных сетях:



Не нашли ответ на свой вопрос?
Напишите нам — мы постараемся дополнить статью или передадим вопрос врачу-консультанту. Это бесплатно.

Имя

Адрес электронной почты

Текст

ВАЖНО

Информация из данного раздела не может служить достаточным основанием для постановки диагноза или назначения лечения. Решение об этом должен принимать врач на основании всех имеющихся у него данных.

Популярные статьи

Бляшки и красные пятна на коже

Кортизол

Аппендицит

Строение женских половых органов

Задержка месячных

Вам телеграм.

Telegram-канал,
которому, на наш взгляд,
можно доверять

Оставить вопрос

Поделитесь статьей в соцсетях!



Главная Гемотест Live Справочник Заболевания Угри (акне)

Закажите
исследования
с выездом
на дом

Запишитесь
на онлайн-
консультацию
специалиста

Проверьте
скидки
и предложения
от партнёров

Используйте
бонусы
в программе
лояльности

К началу страницы

ПАЦИЕНТАМ БИЗНЕСУ КОМПАНИЯ

Каталог анализов Выезд на дом

- Медицинские услуги
- Налоговый вычет
- Гемотест Клуб + Бонус
- Обратная связь

Вход для партнеров

- Карта сайта
- Оплата и возврат
- Правовая информация
- ЦУР
- Использование Cookie
- Возрастное ограничение 12+

© ООО «Лаборатория Гемотест». Все права защищены.